
PROGRAMA DE SALUD VISUAL

Vecinos que vuelven a ver. Municipios que previenen la ceguera.

Un convenio de precios preferenciales entre el municipio y un centro oftalmológico para operar cataratas y prevenir la ceguera evitable en personas sin cobertura.

El problema

La ceguera por catarata es evitable — pero muchos vecinos no pueden costear la cirugía

1.^a

CAUSA

La catarata no operada es la principal causa de ceguera reversible en adultos mayores.

Miles

EN ESPERA

Personas sin obra social que quedan fuera del sistema y engrosan las listas de espera públicas.

Alto

COSTO PRIVADO

El valor de la cirugía privada es inaccesible para la población de bajos recursos.

Resultado: personas que pierden autonomía y calidad de vida por una cirugía de bajo costo relativo y alto impacto.

La propuesta

Precio preferencial: el Centro incluye el descuento, el Municipio paga el valor final, el vecino se opera gratis

Descuento

El Centro aplica

Incluye el descuento del Programa en el precio de cada práctica.

Precio final

El Municipio financia

Paga el valor final de las prestaciones realizadas a sus vecinos.

\$0

El vecino recibe

Accede a la cirugía sin costo (o con un copago mínimo).

Los valores son precios finales, con el descuento del Programa ya incluido. Lo que importa jurídicamente es el diseño transparente y auditable.

Fundamento jurídico

Es legal: el municipio tiene competencia en salud y puede pagar prestaciones a sus vecinos

Derecho a la salud operativo

Constitución Nacional (arts. 42 y 75 incs. 22 y 23) y CSJN, «Campodónico»: el Estado, en todos sus niveles, debe garantizar la salud.

Autonomía y competencia municipal

Constitución de Córdoba: autonomía municipal (art. 180) y competencia en salud, discapacidad y asistencia social (art. 186, inc. 7).

Facultad de convenir

Ley Orgánica Municipal N.º 8102 y art. 190 Const. Cba.: el municipio puede celebrar convenios y comprar prestaciones de salud.

Prevención de discapacidad

Leyes 22.431 y 24.901 y Convención de Discapacidad: prevenir la ceguera evitable es una acción positiva a favor de grupos vulnerables.

La clave: gasto con fin público sanitario, pago contra prestación documentada — nunca una liberalidad al prestador.

Triple beneficio

Todos ganan: el municipio, los vecinos y el sistema sanitario

Para el municipio

- Política de salud de alto impacto y bajo costo
- Gasto controlado por cupo y por prestación
- Gestión transparente y auditable
- El vecino que vuelve a ver agradece y recomienda la gestión

Para los vecinos

- Cirugía gratuita o de copago mínimo
- Recuperan visión y autonomía
- Atención cercana, sin viajar
- Igualdad de acceso a la salud

Para el sistema

- Descomprime listas de espera públicas
- Evita costos de aparatología e infraestructura
- Suma capacidad instalada privada
- Prevención de discapacidad visible

Cómo funciona

Un circuito simple, reglado y trazable — el municipio dirige y controla

1

Elegibilidad

El municipio evalúa y declara elegible al vecino (residencia, sin cobertura, vulnerabilidad).

2

Autorización

Emite la orden de prestación y deriva al Centro dentro del cupo mensual.

3

Cirugía

El Centro realiza la práctica con calidad y seguimiento postoperatorio.

4

Auditoría

El municipio audita la práctica y verifica documentación y resultados.

5

Pago

Se paga el valor final contra factura, al precio del Programa (descuento incluido).

El municipio puede derivar, autorizar, auditar, fijar cupos, priorizar, exigir informes y resultados, y rescindir. Todo ello refuerza la validez del programa.

Modelo económico

El municipio paga bastante menos que el valor particular de mercado

Cirugía de catarata — por ojo, todo incluido (con lente monofocal)

\$1.200.000

Valor particular de
mercado (ref.)

\$850.000

Precio del Programa
(por ojo)

≈ 29%

Ahorro para el
municipio

\$0

A cargo del vecino

Precio final con lente monofocal incluida, ambos ojos, con el descuento del Programa ya aplicado. El valor particular de mercado de referencia surge de precios publicados de cirugía de catarata (lente monofocal, todo incluido) en Argentina 2024-2025 y del rango en dólares (USD 700-1.200 por ojo). Y un dato que vende solo: el vecino que recupera la vista agradece y recomienda el programa — rédito social y político para la gestión.

Gestión del riesgo

Diseñado para pasar el control del Tribunal de Cuentas sin observaciones

Ordenanza y partida previas

El programa se crea por ordenanza, con crédito presupuestario imputado antes del gasto.

Precio de referencia fundado

Nomenclador uniforme (valores APROSS/PAMI o de mercado), no fijado caso por caso.

Expediente por paciente

Elegibilidad, autorización, consentimiento, práctica, factura al precio del Programa e informe médico.

Selección transparente

Programa abierto de adhesión o contratación conforme el régimen: neutraliza la competencia desleal.

Pago contra prestación

Nunca anticipos: se paga la práctica efectivamente realizada y auditada.

Sin superposición de cobertura

Se excluye a quienes tengan obra social vigente (PAMI/APROSS): evita conflictos.

Lección del caso Necochea: se rechazó un convenio opaco y con contraprestación en especie. Aquí: ordenanza, datos y reglas claras.

Indicadores de éxito

Métricas que demuestran el impacto y respaldan la continuidad del programa

N.º

Cirugías realizadas

%

Reducción de lista de espera

≤30d

Tiempo de turno a cirugía

>95%

Éxito quirúrgico / sin complicaciones

AV

Mejora de agudeza visual



Satisfacción del paciente

Reportados en un tablero periódico al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas — transparencia activa.

Implementación

Del acuerdo al primer operado en pocas semanas

M1

Acuerdo y ordenanza

Presentación, convenio marco y sanción de la ordenanza habilitante.

M2

Puesta a punto

Nomenclador, cupos, circuito de admisión y difusión a los vecinos.

M3-4

Primeras cirugías

Derivación, operaciones y seguimiento; auditoría y primeros pagos.

M5-6

Evaluación

Indicadores, informe de impacto y decisión de renovación/ampliación.

Escalabilidad

Empezar chico, probar el modelo, y escalar a toda la provincia

1

Programa piloto

Municipio o comuna pequeño (Ley 8102): trámite ágil, cupo acotado y 6 meses de prueba con métricas.

2

Expansión provincial

Réplica en municipios con Carta Orgánica; mismo modelo (ordenanza + convenio + anexos), ajustado a cada normativa local.

3

Escala nacional

Estructura reutilizable en otras provincias, adaptando la base normativa y el nomenclador de cada jurisdicción.



Propongámoslo juntos

Un programa que devuelve visión a los vecinos y prestigio a la gestión municipal.

Llevamos el paquete completo: nota técnica jurídica · modelo de convenio · proyecto de ordenanza · esta presentación.

Propuesta de inicio: programa piloto de 6 meses, cupo acotado y evaluación por métricas de impacto.